GUIA PRÁTICO · 5 PROMPTS

IA no consultório: o prontuário deixa de ser burocracia.

Cinco prompts completos, prontos para copiar e colar, que devolvem tempo ao que realmente importa: olhar no olho do paciente.

> **"A maior parte do tempo de uma consulta não deveria ser gasta olhando para a tela e digitando prontuário. Deveria ser gasta olhando no olho do paciente."**
>
> GUIA DO INICIANTE · IA PARA MÉDICOS

O que tem dentro: 7 páginas · 5 prompts completos para copiar e colar · regras de uso seguro (LGPD) · checklist de 4 passos para aplicar hoje.

1 Anotação solta → prontuário SOAP completo em segundos	**2** Copiloto de raciocínio clínico: lacunas e sinais de alarme	**3** Triagem pré-consulta humanizada
4 Hipóteses diagnósticas + perguntas de desempate	**5** Carta de orientações pós-consulta para o paciente	**+** Checklist de uso seguro (LGPD) e regras de ouro

Antes de começar: 3 regras de ouro

A IA não substitui o seu raciocínio clínico. Ela elimina a parte mecânica do trabalho e organiza a sua investigação.

NUNCA DADOS IDENTIFICÁVEIS

Use iniciais, idade e sexo. Nunca nome completo, CPF, telefone ou data de nascimento. LGPD: dado de saúde é sensível.

VOCÊ ASSINA

Toda saída é rascunho. Revise, corrija e assuma a responsabilidade técnica antes de salvar no prontuário.

FERRAMENTA CERTA

Prefira modelos com modo privado (sem uso dos dados para treino) e ambiente institucional aprovado.

Importante: os prompts abaixo foram desenhados para uso assistencial e educacional. Não use para diagnóstico automatizado nem para decisões sem revisão médica. Em caso de emergência, o julgamento clínico e os protocolos locais sempre prevalecem.

1 Anotação solta → prontuário SOAP

O campeão de economia de tempo. Você dita/escreve tópicos e recebe um prontuário estruturado.

Quando usar: ao final da consulta, com anotações rápidas no papel, no celular ou ditadas por voz.

PROMPT COMPLETO

```
Você é um médico assistente experiente, especialista em documentação clínica
objetiva em português do Brasil.

Vou te passar anotações soltas de uma consulta. Transforme em um prontuário no
formato SOAP
(Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano), com linguagem técnica, impessoal e
concisa.

Regras:
1. NÃO invente nenhum dado. Se uma informação essencial estiver ausente, escreva
   "[não informado]" em vez de supor.
2. Use apenas abreviações consagradas na prática médica brasileira.
3. No Subjetivo: queixa principal, HDA cronológica e antecedentes mencionados.
4. No Objetivo: exame físico e dados de exames, apenas o que foi registrado.
5. Na Avaliação: hipóteses diagnósticas em ordem de probabilidade, com o
raciocínio em 1 linha cada.
6. No Plano: conduta, prescrições, exames solicitados, orientações e retorno,
separados por tópicos.
7. Ao final, liste em "PENDÊNCIAS" os dados que faltaram e que você precisaria
confirmar.

Anotações da consulta:
[COLE AQUI SUAS ANOTAÇÕES]
```

Dica: peça no fim "gere também a versão de 3 linhas para o resumo de alta" — você economiza outra digitação.

2 Copiloto de raciocínio clínico

Um segundo par de olhos que aponta o que você não perguntou.

Quando usar: casos atípicos, quadro arrastado, paciente que "não fecha" com a hipótese inicial.

PROMPT COMPLETO

```
Atue como um clínico sênior fazendo a revisão de um caso, no papel de copiloto —
não de autoridade.

Abaixo está o resumo do meu caso. Sua tarefa:
1. Listar as LACUNAS da história e do exame que ainda precisam ser esclarecidas
(máximo 8,
   em ordem de importância clínica).
2. Apontar SINAIS DE ALARME (red flags) presentes ou potencialmente presentes, e o
que cada um
   implicaria em termos de urgência.
3. Identificar vieses de fechamento: qual hipótese eu posso estar ancorando cedo
demais e por quê.
4. Sugerir exames ou testes que discriminem melhor entre as hipóteses (os mais
custo-efetivos primeiro).
5. Fechar com "O QUE EU FARIA DIFERENTE HOJE", em 3 linhas, deixando claro que a
decisão é minha.

Formato: tópicos curtos. Sem introdução, sem repetir meu texto. Se faltar dado
essencial, pergunte
antes de concluir.

Caso:
[COLE O RESUMO DO CASO: idade, sexo, queixa, evolução, exame físico, exames já
feitos, hipótese atual]
```

Dica: rode o mesmo caso em dois modelos diferentes e compare as lacunas — as divergências costumam ser o ponto cego.

3 Triagem pré-consulta humanizada

O paciente chega acolhido — e você chega com a história já organizada.

Quando usar: 24 a 48 h antes da consulta, via WhatsApp ou secretária, para consultas eletivas.

PROMPT COMPLETO

```
Você é a equipe de acolhimento de um consultório médico. Escreva mensagens curtas, calorosas e
claras, em português do Brasil, para envio por WhatsApp — nada de linguagem robotizada ou jurídica.

Produza 3 peças:
1. MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO (até 400 caracteres): confirma data/hora/local, o que trazer
   (documentos, exames, medicações em uso) e como reagendar.
2. FORMULÁRIO DE PRÉ-CONSULTA (5 a 7 perguntas objetivas, numeradas, fáceis de responder em áudio):
   queixa principal e tempo de evolução, sintomas associados, medicações e alergias, cirurgias e
   internações, histórico familiar relevante, exames recentes.
3. MENSAGEM DE PREPARO: só o que for indispensável para esta consulta (jejum, bexiga, roupa,
   acompanhante), em no máximo 3 itens.

Contexto da consulta:
[ESPECIALIDADE E MOTIVO / TIPO DE CONSULTA / DURAÇÃO]
```

Dica: o formulário responde por áudio — quem tem 50+ anos responde muito mais por voz do que digitando.

4 Hipóteses e perguntas de desempate

Sai da consulta sabendo exatamente qual pergunta muda a conduta.

Quando usar: antes de pedir exames — evita pedir painel inteiro "para não errar".

PROMPT COMPLETO

```
Liste hipóteses diagnósticas diferenciais para o quadro abaixo e, para cada uma, a pergunta ou
manobra que mais aumenta ou diminui a probabilidade dela (likelihood ratio quando existir).

Formato de saída, para cada hipótese:
- Hipótese | probabilidade subjetiva (alta/média/baixa) | 1 linha de justificativa
- PERGUNTA DE DESEMPATE: a pergunta exata que devo fazer, na ordem em que devo fazer
- MANOBRA/EXAME: o achado que confirma e o que praticamente exclui
- PRÓXIMO PASSO se confirmar / se excluir

Regras:
- Máximo 6 hipóteses, incluindo as "não posso errar" (urgentes), mesmo que improváveis.
- Marque com ⚠ qualquer hipótese que exija ação nas próximas 24 h.
- Se o quadro sugerir emergência, diga isso na primeira linha antes de qualquer diferencial.
- Não invente dados epidemiológicos: se citar frequência, indique que é aproximada.

Quadro clínico:
[IDADE, SEXO, QUEIXA, TEMPO, SINAIS/SINTOMAS ASSOCIADOS, EXAME FÍSICO, EXAMES]
```

Dica: peça "reordene as perguntas na sequência de uma consulta real" — vira um roteiro de anamnese.

5 Carta de orientações pós-consulta

O paciente sai entendendo — e você reduz ligações e retornos desnecessários.

Quando usar: no fim da consulta, junto com a receita. Entregue impresso ou por WhatsApp.

PROMPT COMPLETO

```
Traduza a conduta abaixo em uma carta de orientação para o paciente, em português
do Brasil,
com linguagem simples (nível de leitura: ensino fundamental), sem jargão e sem
termos assustadores.

Estrutura:
1. "O que encontramos" — 3 a 5 linhas, explicando o diagnóstico ou a hipótese em
palavras comuns.
2. "O que fazer agora" — lista numerada, uma ação por linha, com frequência e
duração.
3. "Medicações" — tabela: nome, para que serve, como tomar, por quantos dias,
efeitos comuns.
4. "Sinais de alerta" — o que exige procurar atendimento imediatamente (em lista
curta e clara).
5. "Quando voltar" — data ou critério objetivo de retorno.
6. "Dúvidas" — como falar com a equipe e em qual horário.

Regras: frases curtas (máx. 15 palavras), voz ativa, sem abreviações médicas, sem
promessas de cura.
No máximo 1 página. Ao final, inclua uma linha: "Este material complementa, não
substitui, a consulta."

Conduta realizada:
[DIAGNÓSTICO/HIPÓTESE + PRESCRIÇÃO + ORIENTAÇÕES + RETORNO]
```

Dica: peça também uma versão de 5 linhas para enviar por WhatsApp — é a que o paciente realmente lê.

Como usar em 4 passos

- **Copie o prompt** e cole em um assistente de IA (ChatGPT, Claude, Gemini ou similar).
- **Substitua os campos entre colchetes** pelos dados reais — sem dados identificáveis.
- **Revise a saída** com olhar crítico: corrija o que estiver impreciso ou fora do protocolo local.
- **Salve no prontuário** só depois da sua revisão. A assinatura é sempre sua.

Lembre-se: a IA que escreve o prontuário não examina o paciente. Ela organiza a informação — o julgamento clínico, o exame físico e a relação médico-paciente continuam sendo seus.

Material educacional. Não substitui diretrizes clínicas nem protocolos institucionais.